COLOPROCTOLOGIA · AULA · RETO E CANAL ANAL

Reto e ânus: continência, constipação e doenças orificiais

Como o reto e o canal anal controlam a evacuação, o que acontece quando esse controle falha e como reconhecer hemorroida, fissura, abscesso e fístula.

C

Professor de Coloproctologia

Aula sobre reto, canal anal e doenças orificiais

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

72 horas
janela para abrir e esvaziar a hemorroida trombosada

6 semanas
separam a fissura anal aguda da crônica

50%
dos abscessos anais acabam virando fístula

NESTA APOSTILA

01	O intestino: muito além da evacuação	2
02	Reto e canal anal: quem decide a evacuação	3
03	Incontinência fecal	4
04	Constipação e distúrbios da evacuação	6
05	Exame proctológico e linha pectínea	10
06	Doença hemorroidária	11
07	Fissura anal	14
08	Abscessos e fístulas anais	15
09	Outras doenças e diagnósticos diferenciais	17
10	O essencial da aula	18

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

01 O intestino: muito além da evacuação

ANATOMIA FISIOLOGIA MICROBIOTA

O intestino virou um órgão "da moda", chamado até de segundo cérebro. A ideia antiga era que ele só absorvia alimentos e preparava as fezes para sair. Hoje se sabe que ele faz muito mais do que isso, e que o que acontece nele repercute no corpo inteiro.

O tubo digestivo é um só: começa na boca e termina no ânus. A divisão em partes é didática. No meio do caminho ele conversa com a vesícula biliar, o fígado e o pâncreas, que ajudam na digestão.

Delgado, cólon, reto e canal anal

INTESTINO DELGADO

O grande absorvedor

Principal órgão de absorção de vitaminas, nutrientes e eletrólitos. Mede de 5 a 6 m, todo enrolado no meio do abdome. Com menos de 1 m restante, a sobrevida fica muito difícil: é a síndrome do intestino curto, que não foi tema desta aula.

INTESTINO GROSSO

Cólon

Tem cerca de 1,5 m e forma um U invertido. Absorve água e os últimos resíduos e forma o bolo fecal. Ao contrário do delgado, pode ser retirado por completo: a pessoa vive uma vida praticamente normal, com algumas mudanças.

O delgado desemboca no cólon pela válvula ileocecal. Daí o caminho segue pelo ceco, onde fica o apêndice, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide (a "dobrinha" final), reto e ânus. O reto e o canal anal coordenam a evacuação e concentram muitas doenças, daí a importância da coloproctologia, uma das especialidades mais antigas da medicina, com relatos anteriores a Cristo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A síndrome do intestino curto costuma ser definida quando restam menos de 200 cm de delgado. Com nutrição pela veia e programas de reabilitação intestinal, hoje há sobrevida mesmo com segmentos bem curtos, embora com grande impacto na vida do paciente.

A mucosa: absorve, secreta, conversa e defende

A mucosa intestinal tem cerca de 32 m², graças às pregas, vilosidades e microvilosidades, todas com papel de absorção e secreção. Ela não é só um cano de passagem:

- **Secreta e absorve.** Libera água, absorve eletrólitos e modula o conteúdo dentro do intestino.
- **Conversa com o cérebro.** Manda mensagens o tempo todo para monitorar a saúde intestinal.
- **Defende o corpo.** É o maior órgão de defesa que temos, porque tudo o que comemos passa por ali e o tecido precisa conviver com as bactérias do intestino.

> “A maior área exposta que a gente tem para o meio ambiente não é a pele, é o intestino.”
>
> PROFESSOR, SOBRE O INTESTINO COMO ÓRGÃO DE DEFESA

O cólon, especificamente, absorve sódio e água e recupera o volume de líquido para que as fezes cheguem com formato pastoso, semissólido. Também libera bicarbonato e potássio, que ajudam no equilíbrio do corpo, e produz os movimentos propulsivos (peristálticos) que levam as fezes em direção ao ânus.

Motilidade: um movimento que precisa de maestro

O estímulo para o movimento vem do sistema nervoso entérico, o sistema nervoso próprio do intestino. As células intersticiais de Cajal funcionam como receptoras desses nervos e como um marca-passo, que modula e coordena a contração.

A coordenação é tão importante quanto a força. Se dois segmentos vizinhos contraíssem ao mesmo tempo, as fezes ficariam indo e voltando, sem avançar. O movimento precisa ser em sequência.

Microbiota e hormônios intestinais

A microbiota é o conjunto de bactérias, fungos e vírus que vivem em simbiose conosco, principalmente no cólon. O sistema de defesa do intestino precisa viver em harmonia com elas, porque essas bactérias ajudam a secretar hormônios, protegem a mucosa, liberam substâncias que participam do aproveitamento de vitaminas e produzem enzimas digestivas.

Hoje a microbiota é o "carro-chefe" da maioria das pesquisas: há estudos ligando o seu dano à doença inflamatória intestinal, a doenças mentais e neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e à obesidade.

O HORMÔNIO DAS CANETINHAS NASCE NO INTESTINO

O peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (conhecido pela sigla GLP-1), usado nas "canetinhas", é produzido no fim do intestino delgado, no íleo, e age no corpo todo. Quando sua concentração aumenta, a pessoa perde a fome e o controle do diabetes melhora.

Por isso um intestino doente, inflamado ou parado, como na constipação, com as fezes presas por muito tempo, prejudica a produção desses hormônios. A repercussão não fica no intestino: atinge o sistema inteiro.

02 Reto e canal anal: quem decide a evacuação

FISIOLOGIA ANORRETAL · CONTINÊNCIA

O reto foi por muito tempo um órgão "escanteado". Hoje se sabe que boa parte da qualidade de vida depende dele: quem não evacua todos os dias ou tem dificuldade para evacuar costuma viver com irritação e desconforto. E quem coordena 70 a 80% da evacuação não é o intestino como um todo, é o reto.

ÓRGÃO SENSORIAL

Sabe o que está chegando

O reto é um dos poucos órgãos que distinguem gás, sólido e líquido. Com diarreia, ele avisa que é preciso correr ao banheiro; com gás, deixa saber que dá para soltar sem problema; com fezes sólidas, permite escolher o momento certo.

ÓRGÃO MOTOR E RESERVATÓRIO

Guarda e depois elimina

São os 12 a 15 cm finais do intestino. Sente, armazena quando não dá para ir ao banheiro e promove a eliminação com movimentos específicos. Essa noção social de não evacuar em qualquer lugar nos distingue de outros animais.

Os músculos da continência

No final do reto ficam os esfíncteres anais, interno e externo, principais responsáveis pela continência. Junto com eles atuam o músculo puborretal e o levantador do ânus. Esse conjunto decide o rumo: se funciona de forma inadequada, a pessoa fica constipada; se está enfraquecido, fica incontinente.

Reflexo inibitório retoanal PROVA

Quando as fezes chegam e distendem o reto, o esfíncter anal interno relaxa por um instante. Isso deixa o conteúdo encostar na mucosa do canal anal, que "prova" e identifica se é líquido, gás ou fezes sólidas. É um reflexo de entendimento um pouco complexo, mas que cai em muitas provas de residência.

	Continência	Evacuação
RETO	Funciona como reservatório e distingue gás, líquido e sólido	Reconhece que há fezes na ampola retal
PRESSÃO	Pressão de fechamento no canal anal	Aumento da pressão dentro do abdome
MÚSCULOS	Esfíncteres contraídos	Relaxamento dos músculos anais e queda da resistência
COMPORTAMENTO	Capacidade de adiar a evacuação	Saída das fezes

GUARDE PARA A PRÓXIMA AULA

Esta aula cobre constipação, distúrbios da evacuação e as doenças do reto e do ânus. As doenças do cólon ficaram para a última aula.

03 Incontinência fecal

DEFINIÇÃO · FATORES DE RISCO · TRATAMENTO

Incontinência fecal é não conseguir reter as fezes. Uma perda eventual pode acontecer com qualquer pessoa e não fecha diagnóstico. O sinal de alerta é a perda involuntária que se repete por mais de três meses.

CRITÉRIO DE TEMPO

Perda involuntária de fezes ou gases que se mantém por esse período já caracteriza incontinência.

3 meses
OU MAIS DE PERDAS

É um problema de enorme constrangimento: ninguém chega dizendo "estou escapando fezes" ou "estou escapando gases". Por isso o diagnóstico é difícil e quem atende, principalmente pacientes de meia-idade e idosos, precisa perguntar ativamente.

ARMADILHA

Por vergonha, muitos idosos escondem a incontinência. A família acha que estão deprimidos ou doentes, e às vezes eles acabam tratados como depressão ou internados em casas de apoio. Nos Estados Unidos, a incontinência é a maior causa de internação em asilos. Sempre pergunte.

Conforme as fezes chegam, o reto se distende e aumenta sua complacência, ou seja, a capacidade de armazenar. Ao atingir o limite, ele desencadeia o movimento de evacuação.

CAPACIDADE DO RETO

Acima desse volume o reto não consegue mais armazenar e dispara a evacuação.

até 300 mL
DE FEZES

Fatores de risco

IDADE	O envelhecimento enfraquece músculo e nervo.
PARTO NORMAL	É o principal fator. Sem condução e preparo adequados, as lesões obstétricas levam ao prolapso de órgãos pélvicos (queda da bexiga e do útero) e à incontinência fecal.
CIRURGIA ANAL	Um princípio da cirurgia de hemorroida, por exemplo, é achar os marcos anatômicos para não cortar o músculo.

DOENÇA INFLAMATÓRIA	A doença inflamatória intestinal pode destruir o complexo esfincteriano.
RADIAÇÃO	Radioterapia para câncer de próstata ou de útero.
NEUROLÓGICAS	Alzheimer, depressão e demência: é preciso separar o que é causa e o que é consequência.
HÁBITO INTESTINAL	Diarreias frequentes vencem até um complexo esfincteriano razoável.

A causa mais comum é a obstétrica, que lesa diretamente o esfíncter. Essa lesão pode aparecer até 20 anos depois: a mulher compensa por anos, e na menopausa, com a queda dos hormônios, o músculo enfraquece mais rápido e a incontinência surge. Outras causas são as lesões cirúrgicas e a neuropatia por dentro do músculo, por diabetes, envelhecimento ou prolapso.

Exames da função anorretal PROVA

FUNÇÃO

Manometria anorretal

Uma sonda fina entra pelo ânus e o paciente faz os movimentos de contrair, relaxar e fazer força de evacuação. Mostra se os músculos estão funcionando.

ANATOMIA

Ultrassonografia endoanal ou endovaginal

Mostra a anatomia: se há músculo rompido ou alguma lesão no esfíncter.

Classificar a gravidade

Como quase tudo na medicina, a incontinência tem escores. Não são cem por cento confiáveis, mas classificam o quadro em leve, moderado ou grave. Pontua-se a perda de sólido, de líquido e de gás, o uso de fralda ou forro e a mudança no estilo e na qualidade de vida, cada item conforme a frequência (raramente, às vezes, sempre).

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O escore mais usado é o de Wexner, da Cleveland Clinic. A soma vai de 0, continência perfeita, a 20, incontinência completa. Na transcrição a escala apareceu invertida ("20 é continência total"); vale conferir no slide.

Tratamento: difícil e sem padrão-ouro

Nenhum tratamento resolve todos os casos. A escada segue esta ordem:

1. **Manejo clínico.** Melhorar a consistência das fezes, principalmente se houver diarreia. Fezes mais firmes escapam menos.
2. **Fisioterapia pélvica com biofeedback.** Fortalece a musculatura. Funciona quando o músculo não está completamente rompido.
3. **Cirurgia.** Fecha o músculo que rompeu, em casos selecionados.

O MELHOR HOJE

Neuroestimulador sacral

Um "marca-passo": um eletrodo na terceira ou quarta raiz sacral manda estímulo direto ao músculo, que contrai mesmo fraco. Ajuda porque, além da ruptura, esses pacientes têm lesão do nervo. O problema é o custo; sai pelo convênio ou, no Sistema Único de Saúde, por via judicial.

CIRURGIA

Esfincteroplastia em sobreposição

O músculo é circular; quando rompe, as pontas são costuradas uma sobre a outra (técnica de "overlap"). Funciona por pouco tempo se o músculo não tiver força ou o nervo não mandar estímulo. Na prática, o músculo pode estar rompido em 180 graus, isquêmico ou fibrótico.

Já se tentou criar esfíncteres artificiais, com mecanismos de compressão, mas não funcionaram: causam dor e podem perfurar o reto. Fica como registro de uma tentativa da medicina de evoluir.

04 Constipação e distúrbios da evacuação

DEFINIÇÃO · MECANISMOS · DIAGNÓSTICO · TRATAMENTO

A constipação é o oposto da incontinência e talvez a doença mais comum do mundo, embora quase ninguém a chame de doença. Muita gente acha que só é constipado quem não vai ao banheiro, mas a definição é mais ampla.

Critérios de Roma

Uma sociedade que estuda os distúrbios funcionais do intestino criou os critérios de Roma (o professor citou a quinta edição). Cada item abaixo marca um ponto:

ESFORÇO	Fazer força para evacuar em 25% das vezes, ou seja, em uma a cada quatro evacuações.
INCOMPLETA	Sensação de que a evacuação não foi completa e é preciso voltar ao banheiro.
FEZES DURAS	Fezes endurecidas.

MANOBRAS	Precisar ajudar com a mão (manobras digitais) para evacuar.
FREQUÊNCIA	Menos de três evacuações por semana.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Nos critérios de Roma IV (2016), o diagnóstico de constipação funcional exige dois ou mais itens, presentes nos últimos três meses e com início há pelo menos seis meses. Há ainda um sexto item: sensação de bloqueio na região anorretal em mais de 25% das evacuações.

ARMADILHA

No consultório é comum ouvir "fico 7, 10 dias sem evacuar, mas não me incomoda". Isso é doença e é fator de risco para outras: as fezes paradas mantêm toxinas e restos expostos ao intestino, e as bactérias que precisariam se renovar vão morrendo.

Curiosamente, países mais pobres, como os da África, têm menos constipação. O motivo é a alimentação: comem mais raízes, verduras e frutas e têm pouco acesso a fast food e comida industrializada.

Como a evacuação acontece

Dois sistemas precisam funcionar: o cólon, com o peristaltismo coordenado que faz o conteúdo andar, e a região anorretal, a "porteira" que regula se as fezes podem sair ou não. Num lugar socialmente adequado, a pessoa senta e a sequência é automática:

1. **Fecha a glote** e aumenta a pressão dentro do abdome.
2. **O levantador do ânus atua** e a atividade motora do reto é estimulada.
3. **O puborretal relaxa.** Esse músculo, que mantém o reto dobrado num ângulo, solta: o ângulo anorretal se abre e o reto fica reto mesmo.
4. **O canal anal encurta e se abre** e as fezes saem.

Quando esse mecanismo falha, vem a constipação. Com o tempo o reto vai se dilatando, e quanto mais dilatado, mais difícil evacuar.

Os dois tipos de constipação

	Trânsito lento	Distúrbio de evacuação
ONDE	No cólon	No reto e no canal anal
O QUE É	O "intestino preguiçoso", que demora a levar o conteúdo adiante	Anismo, contração paradoxal ou dissinergia pélvica: o músculo fecha em vez de abrir
FREQUÊNCIA	É o que o paciente costuma achar que tem	É o que a maior parte das pessoas tem

A contração paradoxal é como um espasmo: na hora de evacuar, o músculo que deveria abrir se fecha. Dois mecanismos alimentam isso:

- **Aprendizado de segurar.** Quem segura a vontade por anos ensina o músculo que, quando vem a vontade, é para fechar.
- **Dor que gera contração.** Fezes seguradas ficam mais duras e machucam ao sair; a resposta natural do corpo à dor é contrair, e o músculo fecha ainda mais.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Por isso a mulher tem mais esse problema. Ela costuma evacuar só no banheiro de casa: se tem vontade na rua ou viajando, segura. O homem é "mais sem-vergonha" e usa até o banheiro da rodoviária. O músculo dela aprende que é para fechar.

Como investigar

O diagnóstico é clínico: normalmente a conversa já basta. Quando é preciso saber qual mecanismo predomina, há dois exames.

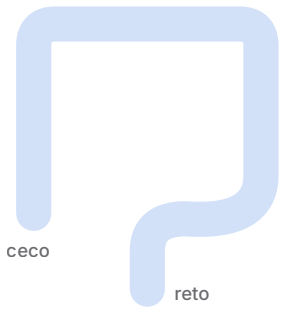
NÃO INVASIVO

Tempo de trânsito com marcadores radiopacos

O paciente toma uma cápsula cheia de bolinhas que aparecem no raio X. Faz-se raio X no primeiro, no terceiro e no quinto dia. É um exame meio chato de fazer, mas útil para entender o mecanismo.

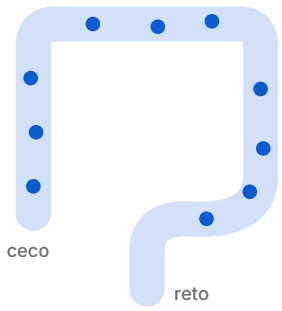


No quinto dia, em teoria, todos os marcadores já foram eliminados. Onde eles ficam presos aponta o mecanismo.



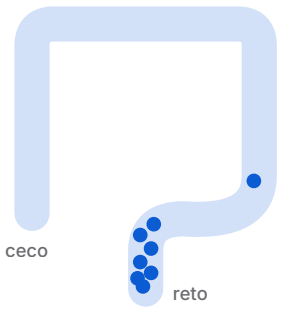
Nada retido

Marcadores eliminados até o quinto dia: trânsito normal.



Espalhados pelo cólon

Retidos ao longo do intestino grosso: constipação de trânsito lento.



Acumulados no reto

Retidos no reto: distúrbio de evacuação (anismo, dissinergia).

INVASIVO

Defecografia

Contraste injetado pelo reto, o paciente sentado numa cadeira especial e orientado a evacuar enquanto se fazem imagens de raio X. Mostra todo o mecanismo, mas caiu em desuso: os pacientes não querem fazer e os serviços de radiologia também não, pelo constrangimento.

ARMADILHA

E a colonoscopia?

Praticamente não serve para avaliar constipação. Só entra se houver suspeita de câncer ou de outra lesão; não é o exame para diagnosticar constipação.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

Na residência, ele fazia defecografia todos os dias porque o professor dele estava no doutorado. Era chato de verdade, e o paciente fica constrangido: se as mulheres já evacuam de um jeito diferente fora de casa, imagine sendo filmadas.

Tratamento

1. **Fibras e água.** A primeira coisa é olhar a alimentação. A maioria das pessoas consome pouca fibra e pouca água, e o intestino fica ressecado.
2. **Laxantes osmóticos.** Os mais leves, para ver se o intestino responde.
3. **Laxantes estimulantes: evitar.** É polêmico. O mito de que causam câncer (como se dizia da cáscara-sagrada) caiu, mas eles irritam bastante o intestino e dão muita cólica.
4. **Medicamentos novos.** Agem nos receptores dos hormônios intestinais que comandam a motilidade, sem irritar a parede, como a prucaloprida.

Assoalho pélvico: fisioterapia, não remédio

Quando o problema está nos músculos do assoalho pélvico, que não relaxam ou não têm força para empurrar, o tratamento de escolha não é remédio: é a fisioterapia pélvica. Ela fortalece o que precisa de força e coordena o que funciona fora de hora. Quem toma laxante a vida toda melhora em parte, mas não trata a causa.

- **Biofeedback.** Exercício que corrige a falta de coordenação (a dissinergia).
- **Eletroestimulação.** Aparelhos que estimulam nervos e músculos.
- **Exercícios de Kegel.** Famosos pelo fortalecimento vaginal; podem ser usados, mas não são os mais adequados para o reto.

O CASO QUE O PROFESSOR CONTOU

Uma paciente ficava mais de 20 dias sem evacuar e já tinha tomado todos os laxantes. A manometria mostrou que o músculo não relaxava, e ele indicou fisioterapia. Ela ficou tão brava que ele achou que ia apanhar. Dois ou três meses depois, voltou ao consultório e lhe deu um abraço.

> “Doutor, desde a infância eu não sabia o que era fazer cocô todos os dias.”
>
> PACIENTE DO PROFESSOR, DEPOIS DA FISIOTERAPIA PÉLVICA

> “A fisioterapia é igual academia: não é gostoso, é chato, mas tem que fazer com frequência.”
>
> PROFESSOR, SOBRE MANTER A MUSCULATURA

Resumo: músculo, local e tratamento

INCONTINÊNCIA	Músculo rompido	Músculo íntegro
TRATAR COM	Cirurgia e neuroestimulador	Fisioterapia para fortalecer e neuroestimulador

CONSTIPAÇÃO	Problema no cólon (trânsito lento)	Problema no reto e canal anal
TRATAR COM	Mudança de estilo de vida, fibras, laxantes e medicamentos modernos, como a prucaloprida	Fisioterapia pélvica e biofeedback; em casos selecionados, o neuroestimulador, limitado pelo custo

Do "rodapé dos livros"

As provas de residência têm cobrado detalhes de rodapé. Três doenças ligadas à constipação para reconhecer:

CRIANÇAS

Doença de Hirschsprung

Megacólon congênito. Falta o nervo que manda o músculo do ânus relaxar; ele fica hipertônico e nunca relaxa, e o intestino dilata. O bebê com colostomia costuma ter essa doença.

APÓS GESTAÇÕES

Retocele

Fraqueza do septo entre reto e vagina. As fezes entram numa bolsa e empurram a vagina, que abaula. Muitas precisam pôr o dedo na vagina para conseguir evacuar.

TRAUMA DAS FEZES

Úlcera retal solitária

Úlcera isolada no reto, causada pelas fezes endurecidas que machucam a parede. Pode ser confundida com doença inflamatória intestinal.

CONSTIPAÇÃO PUXA OUTRAS DOENÇAS

Fezes ressecadas e o esforço machucam o ânus e aumentam a chance de hemorroida, fissura, fístula e abscesso. A constipação também aumenta a chance de divertículos e, pelo tempo maior de exposição a toxinas e agrotóxicos, de câncer. Por isso merece ser levada a sério.

05 Exame proctológico e linha pectínea

EXAME FÍSICO · ANATOMIA

As doenças orificiais, as do canal anal, são principalmente quatro: hemorroidas, fissuras, abscessos e fístulas. Antes delas, o maior tabu da proctologia: o exame físico. O paciente tem vergonha, e muitos médicos também evitam. No ambulatório, o paciente às vezes fica constrangido com cinco ou seis pessoas na sala. Mas o exame segue a lógica que vocês já conhecem.

1. **Posição.** Decúbito lateral esquerdo.
2. **Inspeção.** Olhar a pele como um dermatologista: vermelhidão, calor local, pus, ferida.
3. **Palpação e toque retal.** Ao redor, procura tumor ou massa. O toque identifica tumor, massa ou nódulo, e avalia o tônus: se o músculo tem força, se está apertado demais, relaxado demais ou com defeito. Não existe percussão nesse exame.
4. **Anuscopia.** O anuscópio é o "espéculo anal": entra pelo ânus para ver se há doença no canal.

ALERTA

Não é raro o paciente com dor anal passar quatro ou cinco vezes pela unidade de pronto atendimento sem que ninguém olhe a região, e o abscesso segue crescendo. Essa infecção pode se espalhar por todo o tecido, chegar ao abdome e levar à morte. Tumores também passam batido por falta de toque.

> “Se você não quiser fazer o toque, pelo menos dá uma olhadinha.”
>
> PROFESSOR, SOBRE O PACIENTE COM DOR ANAL NO PRONTO-SOCORRO

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A forma grave da infecção perineal que se espalha pelos tecidos é a gangrena de Fournier, uma infecção necrosante e de evolução rápida, que exige cirurgia de urgência.

Linha pectínea: o divisor do canal anal

A linha pectínea separa a mucosa do reto, uma faixa de mucosa de transição e a pele do ânus. Saber se uma doença está acima ou abaixo dela facilita o entendimento e explica a dor.

	Acima da linha pectínea	Abaixo da linha pectínea
REVESTIMENTO	Mucosa do reto	Pele
DOR	Praticamente não dói: dá para cauterizar ou beliscar sem dor	Dor intensa, como a que o paciente sente depois de operar hemorroida
HEMORROIDA	Interna	Externa

06 Doença hemorroidária

CONCEITO · CLASSIFICAÇÃO · TRATAMENTO

Não são varizes: são coxins vasculares

Antigamente se dizia que hemorroidas eram varizes. Hoje as provas cobram o conceito correto: são coxins vasculares, abaulamentos formados por comunicações (anastomoses) entre artérias e veias, presentes em todo ser humano. Quando esses coxins se dilatam e dão sintomas, passa a ser doença hemorroidária.

A dilatação vem do aumento de pressão, como na gestação e na constipação, e de fator genético: muitas famílias têm fraqueza vascular hereditária. O mecanismo segue uma sequência:

1. **Agressão mecânica.** Esforço físico e esforço para evacuar, somados à idade, machucam a região.
2. **Inflamação e congestão.** Aumentam o fluxo de sangue e a estase venosa, e os coxins crescem.
3. **Perda da fixação.** Os coxins dilatados se soltam e saem para fora: é a hemorroida.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A irrigação ficou truncada na transcrição. Em linhas gerais, as hemorroidas internas vêm do plexo retal superior, ligado à artéria retal superior; as externas, do plexo retal inferior, ligado às artérias retais inferiores, ramos da pudenda interna.

Tipos

Internas e externas

Internas ficam acima da linha pectínea; externas, abaixo. Não é incomum ter as duas, que se chamam mistas.

Trombosada e plicoma

Na trombosada forma-se um coágulo dentro da veia, com muita dor. O plicoma é a pele que sobra quando uma hemorroida externa inflama e depois cicatriza.

Fatores de risco: gestação, constipação, diarreia frequente, doenças do colágeno, obesidade, sedentarismo, pouca fibra na dieta e até cirrose.

Classificação das hemorroidas internas PROVA

Muito cobrada em prova e muito útil no dia a dia, porque orienta o tratamento. Vale só para as internas.

	O que acontece	Conduta
GRAU I	Não sai para fora. É pequena e, no máximo, sangra sem dor.	Clínica: pomada e medicação para aliviar o sintoma.
GRAU II	Sai ao evacuar ou fazer força e volta sozinha, sem empurrar.	Se o sangramento ou o prolapso incomodam, procedimento: principalmente a ligadura elástica.
GRAU III	Sai e o paciente precisa empurrar de volta, um ritual a cada evacuação.	Ligadura se for pequena; em geral, cirurgia.
GRAU IV	Fica para fora o tempo todo e não volta.	Com sintoma, indicação cirúrgica.

> "O que indica a cirurgia é a sintomatologia, mais do que o tamanho."
>
> PROFESSOR, SOBRE QUEM TEM HEMORROIDA E QUEM PRECISA OPERAR

Ele já viu pacientes com hemorroida grau IV gigantesca dizendo que convivem bem, sem incômodo, e outros com hemorroida mínima, muita dor e indicação de operar. Nem todo mundo que tem hemorroida vai para cirurgia.

Diagnóstico

É clínico: inspeção, toque retal e anuscopia. Se a decisão for operar, dois exames costumam entrar antes:

- **Colonoscopia** se o paciente tem mais de 40 anos, para rastrear câncer colorretal e avaliar as hemorroidas.
- **Manometria anorretal** para ver se o músculo já tem algum dano, porque a cirurgia pode piorá-lo.

Tratamento sem cirurgia

Melhorar a dieta e evitar a constipação: mais líquido e mais fibras. Podem entrar pomadas e venotônicos, remédios que ajudam um pouco na circulação venosa (ele citou várias marcas comerciais). A ação é limitada: servem para o grau I e, no máximo, o grau II.

CONSULTÓRIO

Ligadura elástica

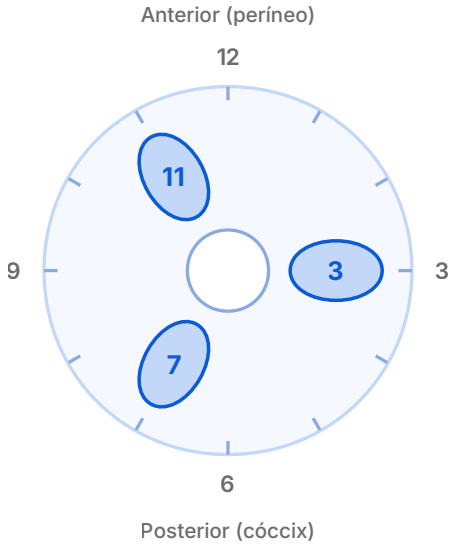
Um aparelho amarra a base da hemorroida com um elástico, e ela cai em 10 a 15 dias. É ambulatorial, não precisa internar e o paciente sai muito bem. Funciona só nos graus I e II.

RESUMO POR GRAU

Quem recebe o quê

Grau I: venotônicos e medidas clínicas, ou ligadura. Grau II: ligadura, e às vezes cirurgia. Grau III: em geral, cirurgia. Grau IV: cirurgia.

Onde as hemorroidas aparecem PROVA



Como se lê

Paciente em posição ginecológica: o 12 fica voltado para o períneo e o 6 para o cóccix, como num relógio.

Os três pontos clássicos

As hemorroidas aparecem com mais frequência às 3, às 7 e às 11 horas, seguindo os três vasos principais.

Na prática

Nem sempre é tão limpo: podem existir mamilos em outras posições, como às 5 ou à 1 hora.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Em posição ginecológica, as 3 horas correspondem à lateral esquerda; as 7 horas, à posterior direita; e as 11 horas, à anterior direita do paciente.

Técnicas cirúrgicas

MILLIGAN-MORGAN	A mais usada no dia a dia. Remove as hemorroidas e deixa a ferida aberta. É bastante eficaz e cicatriza em 20 a 30 dias, mas dói muito: há paciente que chega a desmaiar ao evacuar pela primeira vez.
FERGUSON	Igual na remoção das veias, mas a ferida é fechada com pontos, para reduzir a dor.
GRAMPEADOR	Um aparelho que corta e costura as veias dilatadas ao mesmo tempo.

LIGADURA COM PONTOS	Em vez de cortar, dão-se pontos nos vasos para a hemorroida "secar".
LASER	Corte mais preciso, com menos desconforto.

A COMPLICAÇÃO QUE MAIS PREOCUPA

Feita por quem sabe, a cirurgia tem poucas complicações. Dor e outros desconfortos se resolvem com facilidade. O que preocupa é a incontinência, porque costuma ser irreversível.

Trombose hemorroidária PROVA

É a "bolinha" endurecida e arroxeada, como uma jabuticaba, com muita dor. A prova gosta dessa picuinha: o que decide a conduta é o tempo de evolução.

JANELA DA TROMBOSE

Antes de 72 horas: pequeno corte no próprio consultório para esvaziar o coágulo, com boa resposta. Depois de 72 horas: esperar o processo regredir e operar mais tarde, se preciso.

72 horas
OU TRÊS DIAS

O professor comentou que, na prática, não faz essa abertura, mas que é a conduta descrita nos livros e a que cai na prova.

07 Fissura anal

FISIOPATOLOGIA · AGUDA E CRÔNICA · TRATAMENTO

Tão comum quanto as hemorroidas, a fissura é um corte no canal anal, um trauma causado em geral por fezes duras. Parece um cortezinho de nada, mas causa uma dor terrível, às vezes incapacitante. Quanto mais fundo, mais atinge o músculo e mais dói.

O CICLO VICIOSO DA FISSURA

A fissura se mantém porque a própria dor impede a cicatrização.

CORTE
Fezes duras machucam o canal anal.

ESPASMO
A dor faz o músculo contrair e ficar fechado.

ISQUEMIA
Com o músculo apertado, falta sangue e não cicatriza.

MEDO
O paciente segura as fezes, que endurecem e machucam de novo.

	Fissura aguda	Fissura crônica
TEMPO	Menos de 6 semanas	Mais de 6 semanas
ASPECTO	Corte simples, sem pus nem infecção, borda limpa e nítida	Mais profunda, atinge o músculo, fundo com fibrina e cicatrização inadequada
DOR	Intensa	Ainda maior
CONDUTA	Dieta e pomada simples costumam reverter	Tratamento mais avançado, eventualmente cirúrgico

Sintomas típicos: dor ao evacuar e sangue vivo, aquele sangue limpo que aparece no papel.

Fatores de risco: constipação e trauma, pós-operatório de cirurgias anais, músculo apertado por natureza (o que fecha em vez de abrir), doença inflamatória intestinal, infecções (principalmente tuberculose e sífilis) e alguns tumores.

A tríade da fissura crônica PROVA

A prova gosta de perguntar quais são os três componentes da fissura crônica:

1
A própria fissura
O corte profundo, com fundo de fibrina.

2
Plicoma sentinela
A pelezinha que se forma do lado de fora da fissura.

3
Papila hipertrófica
A pelezinha que se forma do lado de dentro do canal.

Tratamento

O tratamento sem cirurgia começa pela mudança de hábitos: atividade física, frutas, verduras e mais água. As pomadas precisam juntar duas ações, seguindo a fisiopatologia:

Analgesia
Um componente analgésico contra a dor forte.

Relaxamento do músculo
Desfaz o espasmo e aumenta a chance de cicatrizar. Exemplos: nifedipina e isossorbida, que funcionam muito bem.

● POR QUE SE EVITA OPERAR

A cirurgia de melhor resposta é a esfincterotomia: cortar o esfíncter. A dor melhora e a fissura cicatriza, mas o músculo faz falta no longo prazo. Quando o paciente envelhece, tem alta chance de ficar incontinente. Por isso a cirurgia é cada vez mais evitada.

HOJE
Fisioterapia
Muitas vezes com laser, para ajudar na cicatrização e na dor, e para corrigir os mecanismos que perpetuam a fissura.

HOJE
Toxina botulínica
Injetada no músculo, relaxa a musculatura, como no rosto. Resposta muito boa, com custo mais alto.

08 Abscessos e fístulas anais

DIAGNÓSTICO · CLASSIFICAÇÃO · TRATAMENTO

Abscessos são infecções da região anal e perianal, uma área sujeita a traumas frequentes. Quando o abscesso drena, sozinho ou por cirurgia, é comum formar uma fístula: um caminho que liga a parte de dentro do canal à pele de fora. Por isso as duas doenças caminham juntas.

● DO ABSCESSO À FÍSTULA

Depois da drenagem, metade dos abscessos forma uma fístula. É preciso acompanhar.

50%
DOS ABSCESSOS

Abscesso: diagnóstico clínico e rápido

Causa muita dor anal, calor local, vermelhidão e inchaço. Pode haver febre, edema e pus. O exame físico, com inspeção, toque e palpação conforme a localização, basta para o diagnóstico.

IMAGENS QUE O PROFESSOR MOSTROU

- **Nádega toda avermelhada,** com a pele já descascando: abscesso que demorou a ser visto.
- **Abscesso que vazou para o testículo,** por isso demorou tanto a aparecer.
- **Ferida enorme depois da cirurgia,** porque o abscesso corroeu toda a região e só foi possível retirar a pele doente.

Às vezes o paciente "tem sorte": o abscesso drena cedo e forma um buraquinho por onde sai pus e sangue, a fístula. Dói também, mas menos que o abscesso, porque há por onde vazar. Na pele aparece uma pequena marca, parecida com uma espinha.

Classificação das fístulas pelo caminho no músculo

INTERESFINCTERIANA	Passa entre os esfíncteres interno e externo. É a mais comum e, ainda bem, a mais simples.
TRANSESFINCTERIANA	Atravessa o esfíncter interno e o externo.
SUPRAESFINCTERIANA	Acha um caminho por cima do músculo. É uma fístula bem complexa.
EXTRAESFINCTERIANA	Passa por fora de tudo e sobe, perto de órgãos como a próstata.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Essa divisão em quatro tipos é a classificação de Parks, o nome que costuma aparecer nos enunciados.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é clínico, com exame físico e palpação. Para mapear o trajeto, ajudam a ultrassonografia endoanal e a ressonância magnética da pelve.

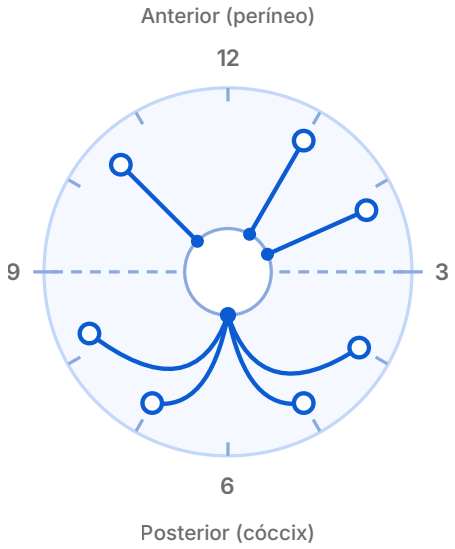
ERRO COMUM

O tratamento da fístula é sempre cirúrgico. Não existe tratamento só com antibiótico ou outro remédio.

A cirurgia retira o trajeto, do orifício interno ao externo, junto com a glândula de origem, e isso permite a cicatrização. O grande cuidado é o músculo: se a fístula passa no meio dos esfíncteres e o cirurgião sai cortando, o paciente fica incontinente. Essa é a dificuldade das fístulas.

Regra de Goodsall PROVA

Não vale em cem por cento dos casos e não é usada na prática, mas cai em prova. Ela prevê onde está o orifício interno a partir de onde está o externo:



Linha transversal
Uma linha imaginária passa pelo meio do ânus, das 3 às 9 horas, e divide o períneo em metade anterior e posterior.

Orifício externo anterior
O trajeto é retinho: vai direto, em linha radial, até a cripta mais próxima.

Orifício externo posterior
O trajeto faz uma curva e termina no meio, na linha média posterior (6 horas).

09

Outras doenças e diagnósticos diferenciais

DIFERENCIAIS · ASSOALHO PÉLVICO

Hemorroidas, fissuras, abscessos e fístulas são as doenças orificiais mais frequentes do dia a dia. Mas há outras que caem em prova, muitas vezes como diagnóstico diferencial.

Parecem fístula, mas não se comunicam com o ânus PROVA

NO CÓCCIX

Doença pilonidal

A "doença do motoqueiro" ou "do cavaleiro". No cóccix, os pelos, em vez de crescerem para fora, entram na pele e formam um túnel de pelos que inflama e forma abscesso. Confunde com fístula, mas fica no cóccix e não tem comunicação com o ânus.

DOENÇA DE PELE

Hidradenite supurativa

Gosta das axilas, da virilha e da região anal. Forma várias pústulas e fístulas, mas também não se comunica com o canal anal. Esse é o principal diferencial.

MUITO PREVALENTE HOJE

Papilomavírus humano

Causa pequenas verrugas perianais. Elas precisam ser removidas e é preciso identificar o tipo do vírus, porque alguns tipos são cancerígenos. O papilomavírus humano é a principal causa de câncer do canal anal.

Prurido anal

ARMADILHA

Todo mundo acha que coceira no ânus é verme. Pode ser, principalmente o oxiúro, mas não é a causa mais frequente: a mais frequente é a hemorroida. Entram no diferencial também a dermatite de contato e o diabetes.

Dor sem lesão e prolapsos

DOR FUNCIONAL

Proctalgia fugaz e síndrome do levantador do ânus

Causam dor anal e entram no diferencial com fissura, mas não há lesão nenhuma. Na proctalgia fugaz, um músculo contrai de repente e se mantém contraído por um tempo: a pessoa acorda à noite com dor, assustada. Na síndrome do levantador, é esse músculo que entra em espasmo.

SAI TUDO

Prolapso retal

A parede do reto sai inteira, em toda a espessura, formando uma lesão extensa para fora. Confunde com hemorroida, mas é muito maior. Aparece em idosos e mulheres com vários partos, que fazem muito esforço para evacuar. É incômodo e doloroso e precisa de cirurgia.

Lesões que pedem biópsia

Herpes simples

Úlceras dolorosas, com aspecto de afta, que podem aparecer na região.

Sífilis

Pode dar fissuras atípicas. O diagnóstico diferencial é o câncer do canal anal.

Estenose anal

O toque descobre. Em geral é pós-operatória ou causada por doença inflamatória intestinal.

O diagnóstico diferencial muitas vezes é difícil, mas é preciso lembrar dessas possibilidades. Normalmente a biópsia define.

Doenças do assoalho pélvico

CISTOCELE	A bexiga desce.
RETOCELE	A parede entre a vagina e o reto enfraquece e forma uma bolsa que abaula a vagina.
PROLAPSO RETAL	O reto sai em toda a espessura; é muito maior que a hemorroida e precisa de cirurgia.

10 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

INTESTINO DELGADO
5 a 6 m
principal órgão de absorção

DELGADO RESTANTE
menos de 1 m
sobrevida muito difícil

CÓLON
1,5 m
pode ser retirado por completo

MUCOSA INTESTINAL
32 m²
área maior que a da pele

RETO
12 a 15 cm
os centímetros finais do intestino

CAPACIDADE DO RETO
até 300 mL
depois dispara a evacuação

PAPEL DO RETO
70 a 80%
da evacuação é coordenada por ele

INCONTINÊNCIA
3 meses
de perdas involuntárias

LESÃO OBSTÉTRICA
até 20 anos
depois pode surgir a incontinência

ROMA: ESFORÇO
25%
das evacuações com força

ROMA: FREQUÊNCIA
menos de 3
evacuações por semana

MARCADORES
dias 1, 3 e 5
raio X do tempo de trânsito

HEMORROIDAS
3, 7 e 11 h
posições clássicas

LIGADURA ELÁSTICA
10 a 15 dias
para a hemorroida cair

MILLIGAN-MORGAN
20 a 30 dias
para cicatrizar

TROMBOSE
72 horas
janela para abrir no consultório

FISSURA
6 semanas
separam aguda de crônica

ABSCESSO
50%
viram fístula

A aula em uma linha por tema

Intestino	Absorve, secreta, conversa com o cérebro, defende o corpo e produz hormônios.
Reto	Órgão sensorial e motor que coordena a maior parte da evacuação.
Incontinência	Perda por mais de 3 meses; principal causa obstétrica; sempre perguntar.
Constipação	Na maioria é distúrbio de evacuação, que se trata com fisioterapia pélvica.
Exame	Inspeção, palpação com toque retal e anuscopia, sem percussão.
Hemorroida	Coxim vascular dilatado; grau orienta, mas o sintoma decide a cirurgia.
Fissura	Ciclo de dor, espasmo e isquemia; crônica com tríade; evitar cortar o esfíncter.
Abscesso e fístula	Diagnóstico clínico precoce; fístula é sempre cirúrgica, poupando o músculo.
Diferenciais	Pilonidal e hidradenite não se comunicam com o ânus; prurido não é sempre verme.

ERROS COMUNS

- **Chamar hemorroida de variz.** São coxins vasculares que se dilatam.
- **Operar pelo grau.** A indicação vem dos sintomas, não do tamanho.
- **Pedir colonoscopia para investigar constipação.** Só se houver suspeita de câncer ou outra lesão.
- **Tratar fístula com antibiótico.** O tratamento é sempre cirúrgico.
- **Dar laxante a vida toda para quem tem dissinergia.** A causa está no músculo: fisioterapia pélvica.
- **Não olhar a região de quem tem dor anal.** O abscesso pode se espalhar e matar.
- **Achar que prurido anal é sempre verme.** A causa mais frequente é a hemorroida.

Do sintoma à suspeita

Sangue vivo, sem dor	Dor forte ao evacuar e sangue no papel	Dor contínua, latejante, com febre	Orifício perto do ânus que drena pus
Hemorroida interna	**Fissura anal**	**Abscesso**	**Fístula anal**
Tratamento clínico: dieta, fibras, água, pomada	Dieta e pomada que relaxa o músculo	Diagnóstico precoce: examinar a região sem demora	Cirurgia, guiada pela regra de Goodsall

Palavras da aula em linguagem simples

Anismo	Contração do músculo do ânus na hora em que ele deveria relaxar para evacuar. O mesmo que contração paradoxal ou dissinergia.
Anuscopia	Exame com o anuscópio, um "espéculo anal", para ver o canal por dentro.
Biofeedback	Fisioterapia em que o paciente vê, num aparelho, a resposta do músculo e aprende a coordená-lo.
Células de Cajal	Células do intestino que funcionam como marca-passo e coordenam o movimento.
Complacência	Capacidade do reto de se distender e guardar mais fezes.
Coxins vasculares	Almofadas de vasos normais do canal anal; dilatados, viram hemorroida.
Defecografia	Raio X feito enquanto o paciente evacua um contraste colocado no reto.
Esfincterotomia	Cirurgia que corta parte do esfíncter; trata a fissura, mas pode deixar incontinência.
Esfíncteres anais	Músculos em anel, interno e externo, que mantêm o ânus fechado.
Fístula anal	Caminho anormal entre o canal anal e a pele, em geral depois de um abscesso.
GLP-1	Sigla do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, hormônio do íleo que tira a fome; é o das "canetinhas".
Linha pectínea	Linha do canal anal que separa a mucosa do reto da pele; abaixo dela dói.

Manometria anorretal	Exame com sonda que mede a força e o relaxamento dos músculos do ânus.
Microbiota	Bactérias, fungos e vírus que vivem no intestino em equilíbrio conosco.
Neuroestimulador sacral	"Marca-passo" com eletrodo numa raiz nervosa do sacro que estimula o músculo do ânus.

Plicoma	Sobra de pele no ânus, que fica depois de uma hemorroida externa ou ao lado de uma fissura crônica.
Prolapso	Órgão que desce e sai do lugar, como a hemorroida ou o reto.
Retocele	Bolsa do reto que empurra a parede da vagina.
Venotônico	Remédio que melhora um pouco a circulação nas veias.

ANOTAÇÕES